PROTOCOLLO 53

Inibizione reciproca dei muscoli elevatori

Rilassare gli elevatori attivando gli abbassatori della mandibola

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, contrattura protettiva	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Spasmo protettivo
- ✓ Dolore acuto dei masticatori
- ✓ Paziente che non tollera l'allungamento

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: seduto.

Fisioterapista: di fronte al paziente, mano sotto il mento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Apertura fino alla prima resistenza.



Attivazione

Il paziente spinge lievemente in apertura contro la tua mano.



Rilascio

Dopo 5 secondi rilassa.



Progressione

Apri lentamente nel nuovo range.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Contrazione	lieve, 5 secondi
Ripetizioni	5
Pausa	5 secondi

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Indicata quando l'allungamento diretto è doloroso
- ✓ Contrazioni sempre lievi
- ✓ Ottimo in fase acuta

Errori da evitare

- ! Contrazioni massimali
- ! Movimento rapido
- ! Dolore durante la tecnica

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura contro resistenza lieve	Mano sotto il mento, spinta lieve in apertura	5 x 5 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** L'inibizione reciproca sfrutta il rilassamento degli antagonisti senza sollecitare il muscolo dolente.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.